PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5004767-05.2022.8.21.0021/RS

AUTOR: SHEILA BARBOSA DALPIZZOLO
AUTOR: ALICE DALPIZZOLO
RÉU: HOSPITAL S P LTDA

SENTENÇA

I - RELATÓRIO

A. D., menor representada por sua genitora SHEILA BARBOSA DALPIZZOLO, e **SHEILA BARBOSA DALPIZZOLO** ajuizaram a presente ação ordinária em face do **HOSPITAL S P LTDA**, relatando, em síntese, que a autora A. D. é portadora de malformação vascular (CID D18.1), necessitando para o seu tratamento do uso contínuo do medicamento SIROLIMUS/RAPAMICINA. Aduziram que o plano de saúde da parte demandada negou a cobertura do tratamento, sob a alegação de que não consta do rol de tratamentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Mencionaram que, na data de 04/10/2021, realizaram a portabilidade do plano de saúde, tendo informado por ocasião da contratação a existência da doença e da necessidade do fornecimento da medicação, o que ensejou o aumento do valor das mensalidades pagas. Sustentaram que a parte ré praticou ato ilícito ensejador de danos morais. Postularam, liminarmente, que fosse determinado à parte ré o fornecimento do medicamento referido. Requereram a procedência da ação, com a confirmação da medida liminar, bem como a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais. Pediram a Gratuidade da Justiça e a tramitação prioritária. Juntaram documentos (Evento 1).

Deferidas a Gratuidade da Justiça e a tramitação prioritária da demanda (Evento 3, DESPADEC1).

Após determinações judiciais (Evento 3, DESPADEC1 e Evento 10, DESPADEC1), a parte autora emendou a petição inicial quantificando os danos morais postulados e regularizando a representação processual (Eventos 8 e 15).

Deferido o pedido liminar (Evento 17, DESPADEC1).

Citada, a parte demandada apresentou contestação (**Evento 33, CONT1**), aduzindo que o medicamento postulado não está inserido no rol daqueles considerados obrigatórios pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Argumentou pela regularidade da negativa de cobertura, aduzindo que agiu no exercício regular de um direito. Alternativamente, sustentou que deve ser observada a coparticipação da parte beneficiária no custeio do fármaco pretendido. Requereu a improcedência do pedido. Juntou documentos (Evento 33, CONTR2).

Houve réplica (**Evento 37, RÉPLICA1**).

No prazo para postulação de provas, apenas a parte autora pediu a produção de prova oral (Evento 43, PET1 e Evento 45, PET1), a qual, embora deferida (Evento 52, DESPADEC1), ficou prejudicada diante do não comparecimento da parte autora e das testemunhas arroladas na solenidade designada (Evento 73, TERMOAUD1).

O Ministério Público opinou pela improcedência do pedido (**Evento 77, PROMOÇÃO1**).

II - FUNDAMENTAÇÃO

Observo que o processo comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, uma vez que as matérias debatidas são fundamentalmente de direito e as provas necessárias à resolução das questões controvertidas já foram anexadas aos autos.

Não havendo questões preliminares a serem apreciadas, passo diretamente ao exame do mérito da causa.

Relativamente ao mérito da demanda, na esteira do parecer do Ministério Público anexada no **Evento 77, PROMOÇÃO1**, convenci-me de que a ação proposta é improcedente.

Inicialmente, consigno que o Código de Defesa do Consumidor (CDC - Lei nº 8.078/90) é aplicável ao caso em tela, estando configurada a relação de consumo, uma vez que a parte autora se enquadra no conceito de consumidor, já que destinatária final do produto fornecido ou serviço prestado pela cooperativa demandada, nos termos do que dispõe o art. 2º, *caput*, do CDC[1], enquanto que a parte demandada configura-se como a sua fornecedora, tal como previsto no art. 3º, *caput*, do mesmo diploma legal[2].

Ademais, o CDC é aplicável aos contratos de planos de saúde, nos termos da Súmula nº 608 do STJ: *"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão"*.

Assim, a avaliação da validade das cláusulas contratuais e a sua interpretação devem observar o respeito à busca do equilíbrio entre as partes, a boa-fé objetiva, o direito à informação clara e adequada sobre os serviços contratados e a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor, admitindo-se, pois, a flexibilização do princípio da *pacta sunt servanda* diante da presunção legal de vulnerabilidade da parte consumidora na relação jurídica de consumo.

Além disso, a demandada submete-se às disposições da Lei Federal nº 9.656/98, que rege os planos e seguros privados de assistência à saúde, conforme dispõe o seu artigo 1º[3].

No caso concreto, é fato incontroverso (arts. 341 e 374, inciso III, ambos do CPC), também comprovado nos autos (vide **Evento 1, OUT18**), que a parte a autora A. D. é portadora de "*MALFORMAÇÃO VASCULAR com predomínio linfático em região cervical, submandibular e hemiface à direita (CID D18.1)*", necessitando para o seu tratamento do uso contínuo do medicamento SIROLIMO (RAPAMICINA).

Em razão disso, a parte autora postula o fornecimento/custeio pelo plano de saúde demandado do referido medicamento.

O plano de saúde demandado negou cobertura ao tratamento de saúde indicado pela médica assistente sob a alegação de que não há previsão de cobertura no rol dos procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS (vide Evento 1, OUT19 e **Evento 1, OUT20**):

> Conforme solicitado, informo que a operadora segue as normativas do Rol
> de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
> A medicação solicitada SIROLIMO 1 MG para administração ambulatorial de
> uso contínuo, não consta no Rol de Procedimentos da Procedimentos da ANS. "

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp nº 1889704/SP e do EREsp nº 1886929/SP, assentou que o rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar é, em regra, taxativo, fixando as seguintes teses:

> *"1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo;*
>
> *2. **A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol**;*
>
> *3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol;*
>
> *4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que:*
>
> *(i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar;*
>
> *(ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências;*
>
> *(iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros;*
>
> *e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS."*

Outrossim, consoante o disposto nos arts. 10 e 12, ambos da Lei nº 9.656/1998, está excluído das exigências mínimas de cobertura assistencial a ser oferecida pelas operadoras de plano de saúde o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (*home care*) e os incluídos no rol da ANS para este fim:

> *Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:*
>
> *(...)*
>
> ***VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12; (...) § 1º As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de regulamentação pela ANS.***

(...)

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: ***(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)***

I - quando incluir atendimento ambulatorial:

c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; (Incluído pela Lei nº 12.880, de 2013) (Vigência)

II - quando incluir internação hospitalar:

g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar; (Incluído pela Lei nº 12.880, de 2013) (Vigência) . *Grifei.*

Nesse mesmo sentido, dispõem os arts. 17 e 18, ambos da Resolução Normativa nº 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS:

Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei nº 9.656, de 1998.

Parágrafo único. São permitidas as seguintes exclusões assistenciais:

(...)

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção dos medicamentos previstos nos incisos IX e X do art. 18, e ressalvado o disposto no art. 13; (...)

Art. 18. O Plano Ambulatorial compreende os atendimentos realizados em consultório ou em ambulatório, definidos e listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme definições constantes na Lei n.º 9.656 de 1998 e regulamentação infralegal específica vigente, não incluindo internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que, embora prescindam de internação, demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a doze horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares, e devendo garantir cobertura para:

(...)

IX - quimioterapia oncológica ambulatorial, entendida como aquela baseada na administração de medicamentos para tratamento do câncer, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes (medicamentos empregados de forma associada aos medicamentos para o tratamento do câncer com a finalidade de intensificar seu desempenho ou de atuar de forma sinérgica ao tratamento) que, independentemente da via de administração e da classe terapêutica, necessitem, conforme prescrição do médico assistente, ser administrados sob intervenção ou supervisão direta de profissionais de saúde dentro de estabelecimento de saúde;

X - medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso, respeitando o disposto nos Anexos desta Resolução Normativa e, preferencialmente, as seguintes características:

a) medicamento genérico: medicamento similar a um produto de referência ou inovador, que se pretende ser com este intercambiável, geralmente produzido após expiração ou renúncia da proteção patentária ou de outros direitos de exclusividade, comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade, e designado pela Denominação Comum Brasileira - DCB ou, na sua ausência, pela Denominação Comum Internacional - DCI, conforme definido pela Lei n.º 9.787/1999; e

b) medicamento fracionado: medicamento fornecido em quantidade distinta da embalagem original, conforme necessidade do paciente e definição do órgão competente, esta atualmente a cargo da ANVISA (...). Grifei

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que é lícita a exclusão, no âmbido da saúde suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA ABUSIVA. ROL DA ANS. NATUREZA. IRRELEVÂNCIA. 1. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da ocorrência de cerceamento de defesa demandaria o reexame fático-probatório dos autos, a atrair o óbice na Súmula nº 7/STJ. 2. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde de medicamento indicado ao beneficiário para tratamento de câncer. 3. ***É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021).*** *4.* ***É obrigatório o custeio pelo plano de saúde de medicamento antineoplásico para tratamento de câncer, sendo irrelevante o questionamento acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do Rol da ANS. Precedentes.*** *5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.031.693/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)*

Assim sendo, o fármaco postulado (Sirolimo/Rapamicina), por ser administrado no âmbito domiciliar e não constituir medicamento antineoplásico, bem como por não contar do rol de tratamentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), não se enquadra nas exceções que ensejam a obrigação da operadora de plano de saúde demandada ao seu fornecimento.

Gize-se que o diagnóstico da autora é de malformação vascular, sendo o medicamento indicado por seus efeitos sistêmico, antiangiogênico e imunossupressor, a ser ministrado no âmbito domiciliar (vide **Evento 1, OUT18**).

Ademais, não obstante as alegações da parte autora em sentido contrário, o tratamento em comento não está expressamente previsto no contrato do plano de saúde entabulado entre as partes (Evento 33, CONTR2), tampouco configura situação de urgência ou emergência a ensejar a cobertura pretendida na exordial.

Nessas circunstâncias, é impositiva a improcedência do pedido de fornecimento, pelo plano de saúde demandado, do medicamento postulado na petição inicial.

Por fim, o pedido de indenização por danos morais igualmente é improcedente, porque, como visto, nenhum ato ilícito foi praticado, tampouco houve defeito na prestação do serviço pela parte demandada (art. 186 do CC e art. 14 do CDC), mormente considerando a licitude da negativa de fornecimento do medicamento pela parte requerid.

Nesse mesmo norte é a orientação do Tribunal de Justiça do Estado acerca do tema:

> *AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. DIABETES MELLITUS NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO. FREESTYLE LIBRE. TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS. MEDICAMENTO DOMICILIAR. NÃO ELENCADO NO ROL DE COBERTURA MÍNIMA DA ANS. RESOLUÇÃO 465/2021. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pela magistrada a quo, que indeferiu a tutela postulada pela parte autora, portadora da enfermidade DIABETES MELLITUS TIPO I (CID 10 - E 10.9), pretendia o fornecimento do kit de sensores FreeStyle Libre Flash (3 unidades mensais), e TO insulina Glardina e Glulisina.Ao atender o comando do art.197 da Carta Constitucional a Lei n. 9656/98, disciplinou os planos e seguros privados de assistência à saúde, como forma de complementar o Sistema Público Saúde (SUS). Com esse propósito foi criada a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), via Lei n.9961/00, que tem por finalidade institucional promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com prestadores e consumidores, de modo a contribuir para o desenvolvimento das ações de saúde no País. Compete a ANS (art.4º), dentre outras diretrizes, elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirá referência básica de assistência (inc.III), com o escopo de garantir um plano de saúde e assistência mínimo de caráter privado, atento às evoluções tecnológicas, sem prejuízo da faculdade da contratação de cobertura mais extensa.Nos termos da Súmula n.608/STJ, adequada à dicção do art.35-G da Lei n.9656/98, ficou expresso que o Código do Consumidor (CDC) tem aplicação subsidiária aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de saúde.Imprescindível considerar que afora a instituição do Plano-Referência de Assistência à Saúde, forte no art.10 da Lei n.9656/98, que garante o mínimo assistencial de caráter negocial privado, há, igualmente, a faculdade de o consumidor contratar plano de assistência à saúde de natureza superior e com maior cobertura, consoante faculta o art.12 do mesmo Diploma Legal. Ambos são regulados pela ANS, a diferença é o valor da contraprestação, o que infirma concluir que é inexorável considerar a natureza da negociação e a espécie de plano assistencial privado em litígio.**No caso telado, trata-se de de infante com 8 anos de idade e que, nos moldes do atestado médico, sofre de diabetes mellitus tipo 1 (CID10.9), doença notadamente grave, postulando tratamento intensivo com os fármacos e aparelho prescrito, sob pena de graves sequelas, existindo risco de óbito. Pontuando a necessidade de monitoramento constante dos índices glicêmicos, observado o risco de hipoglicemias graves, a médica assistente evidencia a imprescindibilidade na utilização do equipamento.O Plano de Referência estabelece exceções (art.10, incs.I a X, Lei n.9656/98), ou seja, hipóteses de não-cobertura, ressalvando-se a contratação facultativa complementar (art.12) e admissão por regulação da ANS (art.10,§1º), que poderá inclusive abranger transplantes e procedimentos de alta complexidade (art.10,§4º). Como consectário, não há como fugir do caráter limitador e taxativo do rol atualizado da ANS, agência reguladora, veiculado via Resoluções, sob pena de colocar em risco a saúde financeira e existencial dos próprios Planos Privados de Saúde.Destaco que não se desconhece o teor da novel legislação nº 14.454/2022, entretanto tal legislação não revogou o disposto no Lei 9.656/98, a qual dispões expressamente quanto à vedação do fornecimento pelo plano de saúde do medicamento domiciliar.** *Assim, deve ser interpretada com as diretrizes e disposições da referida legislação. Descisão mantida.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 51422289720238217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 28-09-2023). Grifei.*

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, **JULGO IMPROCEDENTES** os pedidos deduzidos por **A. D.** e **SHEILA BARBOSA DALPIZZOLO** contra **HOSPITAL S P LTDA**, revogando-se, consequentemente, a medida liminar concedida.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios ao procurador do réu, os quais fixo, com base no art. 85 do CPC, em 10% do valor atualizado da causa, considerando a natureza e a complexidade da matéria, o trabalho desenvolvido e o tempo decorrido até a conclusão do processo.

Suspendo, contudo, a exigibilidade dos ônus sucumbenciais em face da Gratuidade da Justiça que foi deferida à parte autora.

Intimem-se.

Outras Determinações:

- Com o trânsito em julgado da sentença, cumpridas as diligências finais, sem outros requerimentos, arquivem-se os autos, com baixa; e

- Havendo a interposição de recurso de Apelação, deverá o Cartório cumprir as disposições do art. 1.010 do Código de Processo Civil, *independentemente de novo despacho judicial*, salvo nas seguintes hipóteses: art. 331 (apelação contra indeferimento da petição inicial); art. 332 (apelação contra julgamento liminar de improcedência do pedido); art. 485, §7º (extinção do processo sem resolução do mérito); e art. 1.022 (embargos de declaração), todos do Código de Processo Civil, hipóteses nas quais os autos deverão retornar conclusos para apreciação do Juízo.

Documento assinado eletronicamente por **JULIANO ROSSI, Juiz de Direito**, em 10/10/2023, às 17:54:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10047639731v20** e o código CRC **337904a0**.

---

1. Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. ↩
2. Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. ↩
3. Art. 1º. Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade, adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) I - Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor; II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão, que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I deste artigo; III - Carteira: o conjunto de contratos de cobertura de custos assistenciais ou de serviços de assistência à saúde em qualquer das modalidades de que tratam o inciso I e o §1º deste artigo, com todos os direitos e obrigações nele contidos. §1º Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS qualquer modalidade de produto, serviço e contrato que apresente, além da garantia de cobertura financeira de riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica, outras características que o diferencie de atividade exclusivamente financeira, tais como: a) custeio de despesas; b) oferecimento de rede credenciada ou referenciada; c) reembolso de despesas; d) mecanismos de regulação; e) qualquer restrição contratual, técnica ou operacional para a cobertura de procedimentos solicitados por prestador escolhido pelo consumidor; e f) vinculação de cobertura financeira à aplicação de conceitos ou critérios médico-assistenciais. §2º. Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem os produtos de que tratam o inciso I e o §1º deste artigo, bem assim as entidades ou empresas que mantêm sistemas de assistência à saúde, pela modalidade de autogestão ou de administração. (...) ↩